



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : الهام سعيد محمد ابراهيم
المحافظة : الجيزة
الحى / المدينة : الهرم
رقم البطاقة : 27303141301262 رقم التليفون : 01144486362
العنوان : ---
العمر (تاريخ الميلاد) : 14-03-1973 المهنة : ربه منزل
تاريخ تسجيل الإستمارة : 09-10-2026

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإخصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)
المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام تصوير مقطعي للصدر والبطن والحوض بالصبغة
قسم العلاج :
الأورام [11129]

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني
الاسم : د/ندى حسن
الاسم : د/نرمين رمضان
الوظيفة :
الوظيفة :
الوظيفة :
التوقيع :
التوقيع :
التوقيع :
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. /----- /د. /----- /د. /----- /د. /-----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى :
قسم :
جهة العلاج :
نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: الهام سعيد محمد ابراهيم National ID: 27303141301262	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حمید بالثدى و تحتاج الى Contrast-enhanced CT of chest, abdomen and pelvis.

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

الهام
سعيد محمد ابراهيم
٥ تقسيم الصفي - ش سعد زغلول
الهرم - الجيزة

١٩٧٣/٠١ ٢٧٣٠٣١٤١٣٠١٢٦٢

KP8286078

٢٠٢٤/٠٦ ٢٧٣٠٣١٤١٣٠١٢٦٢

ربة منزل

أنثى مسلمة متزوجة
مجدى عبد الحميد محمد حسين

البطاقة سارية حتى ٢٠٣١/٠٦/٢٥

١



KP3286078



٢٧٣٠٣١٤١٣٠١٢٩٣

الجنسية
سيد محمد ابراهيم
د تقسيم القويش سعد زنگران
البحر - الجيزة



٢٧٣٠٣١٤١٣٠١٢٩٣
رقم التعريف
الجنسية
سيد محمد ابراهيم
الطاقة سارية حتى ٢٧٣٠٣١٤١٣٠١٢٩٣





Ministry of health
Central health laboratories
Pathology department

ImmunohistoChemistry report

Report Number: m6728

Female	التاريخ	29/11/2018 12:28	45 Y
التاريخ	06/12/2018 11:15	التاريخ	

Primary Sample :

Paraffin Block

Test :

ER & PR & HER2 neu (ER&PR : Harvey scoring system • Her2neu : CAP scoring system)

Comment :

Technique :

sample recieved was treated by : • CONFIRM anti-estrogen (ER) (SP1) Rabbit monoclonal primary antibody • CONFIRM anti-progesterone receptor (PR) (IE2) Rabbit monoclonal primary antibody.
Sample recieved was treated by : • VENTANA anti-HER2/neu (4B5) Rabbit monoclonal primary antibody using Biotin Detection kit in ventana benchmark OX.

Result :

ER: weak nuclear staining of 80 % of tumour cells

PR: NO nuclear staining of tumour cells

HER2/neu protein over expression : strong continuous membrane staining of > 10 % of tumour cells

Referral Lab :

Comment :

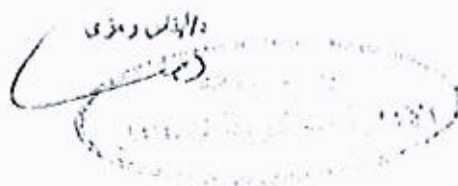
Conclusion :

ER: POSITIVE (SCORE 6/8)

PR: NEGATIVE

HER2/NEU PROTEIN OVER EXPRESSION : POSITIVE (SCORE 3+)

Pathologist:

د. إيمان محمد


Lab Director

19 El-shoikh Rohan Street, Abeideen, Cairo
Tel: (165)7943544 - 7950096 Fax: (202)7948544
Mobile: 01144297292
website: <http://www.healthlabs.net>
email: pathologychl@yahoo.com
facebook: [healthlabs.net](https://www.facebook.com/healthlabs.net)

This Test is not Accredited by EGYPTIAN BOARD OF ACCREDITATION

هذا الاختبار لم يحصل على اعتماد من المجلس المصري للاعتماد

Page 1 of 1



2611/2018
2611/2018
2611/2018

Pathology Report

Name: *الهيثم محمد محمد*

Age: 45 years.

Clinical data: History of right breast cancer with left suspicious lymph nodes.

Specimen Type: Left axillary clearance.

Date: 6/11/2018

Lab. Number: 682

Hospital Number: 2611/2018

Gross Description:

Axillary tissue 9x8 cm entangling 9 nodules, the largest 2.3x2 cm.

Microscopic Examination:

Sections examined revealed lymph nodes, two of them showed foci of atypical round epithelioid cells, likely ductal mammary cells.

Diagnosis:

History of right breast cancer with left suspicious lymph nodes, Left axillary clearance:

- Metastatic deposits of carcinoma in (2/9) lymph nodes.
- Likely of ductal origin.

Prof. Dr. Amr El-Sabca.

Dr. Inas Mohamed Ali.



Pathology Report

Name: *أحمد محمد*

Age: 45 years.

Clinical data: History of right breast cancer with left suspicious lymph nodes.

Specimen Type: Left axillary clearance.

Date: 6/11/2018

Lab. Number: 682

Hospital Number: 2614/2018

Gross Description:

Axillary tissue 9x8 cm containing 9 nodules, the largest 2.3x2 cm.

Microscopic Examination:

Sections examined revealed lymph nodes, two of them showed atypical round epithelioid cells, likely ductal mammary cells.

Diagnosis:

History of right breast cancer with left suspicious lymph nodes. Left axillary clearance.

- Metastatic deposits of carcinoma in (2/9) lymph nodes.
- Likely of ductal origin.

Prof. Dr. Amr El-Sabea.

Dr. Inas Mohamed Ali.



Name: **IBRAHIM SAIED**

Date: **06-02-2020**

POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST: -

Findings:

- Diffuse Parenchymal distortion of right breast with overlying skin thickening.
- Ill defined pleural based consolidative patch with surrounding reticular infiltrates are seen at right middle lobe.
- No hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size and shape with no gross abnormality of the cardiac chambers. Mild pericardial effusion is detected.
- Left port-a-cath is noted.
- Normal appearance of the thoracic aorta and the great vessels.
- Normal appearance of the chest wall.
- Normal appearance of the dorsal vertebrae.
- Upper abdominal cuts are unremarkable.

OPINION:

- *Diffuse Parenchymal distortion of right breast with overlying skin thickening.*
- *Right middle lobe ill defined pleural based consolidative patch with surrounding reticular infiltrates likely inflammatory for clinical correlation & follow up.*
- *Mild pericardial effusion.*

Dr. Ibrahim Elsedawy, M.Sc

Dr.m.gomaa,md



Patient Name	إلهام محمد محمد	Date	1/10/2018
--------------	-----------------	------	-----------

ABDOMEN AND PELVIS ULTRASONOGRAPHIC EXAMINATION REVEALED:-

Liver: Average size (15 cm at RT MCL) with bright homogenous hepatic parenchymal echopattern and smooth surface contour. No focal lesions or intra hepatic biliary radicle dilatation. Portal vein is not dilated.

Gallbladder: Average distention with no evidence of stones, masses or mud inside. Average wall thickness. CBD is not dilated.

Spleen: Average size (9.6 cm in long axis) with homogenous parenchymal echopattern. No focal lesion. Splenic vein is not dilated.

Pancreas and para-aortic region: Concealed by gases.

Kidneys: Both are of average size, normal position and shape, average parenchymal thickness and echogenicity with good corticomedullary differentiation. No stones or back pressure changes. No focal cystic or solid mass lesions.

Urinary bladder: Average distension with normal wall thickness. No stones, masses or diverticular out pouching.

Uterus: Anteverted flexed uterus with average size and normal homogeneous myometrium, measures about 8 X 5 X 3 cm. Average endometrial thickness with normal echopattern, measures about 9 mm. No uterine masses or content seen.

Both ovaries and adnexa: Left ovary showing a cyst measuring about (3.5x3.2cm) showing internal septations, no soft tissue component, no internal vascularity. Right ovary is Average size with normal shape and echogenicity of both ovaries. No cystic or solid adnexal mass lesions.

No abdominal or pelvic collections. No gross mass lesions seen.

Opinion:-

- Bright likely fatty liver for LAR correlation
- Left ovarian complicated cyst for follow up.

Name: Elham Saeld Mohamed

Date: 9 October 2021

ABDOMINAL AND PELVIC ULTRASONOGRAPHY REPORT

- ☐ **Liver:** is mild enlarged in size displaying homogenous bright echopattern with no definite focal lesions or intrahepatic biliary radicles dilatation.
- ☐ **PV:** is patent & of normal caliber with hepato-petal flow.
- ☐ **Gall Bladder:** is partially distended harboring few stones sizes below 5-9 mm.
- ☐ **CBD:** is of average caliber containing no stones.
- ☐ **Spleen:** is average in size displaying homogenous echopattern with no focal lesions.
- ☐ **Both kidneys:** are of average site, size, shape with average cortico-medullary differentiation & normal parenchymal echogenicity. They contain no significant back pressure changes and no sizable stones.
- ☐ **Pancreas & para-aortic area:** gas obscured.
- ☐ **Urinary bladder:** is of average distension regular non thickened walls showing no stones, masses or diverticular outpouchings.
- ☐ **Pelvis/Both adnexa** show no solid or cystic pathologies.
- ☐ No pelvi-abdominal free fluid.

CONCLUSION

- Mild fatty hepatomegaly.
- Calcular gall bladder.
- Moderate bowel gaseous distension.

Ds. Sherif Mostafa, M. Sc.

Patient: Doctor Ekram Saeed

Date: 10-10-2021

BILATERAL BREAST MAMMOGRAPHY AND HIGH RESOLUTION ULTRASOUND

Indication:

- Patient had right CBS.

Technique:

- Bilateral MLO and CC views
- Bilateral breast ultrasound

Report:

- Scattered fibro glandular densities (ACR BI)
- Post-operative changes of the right breast in terms of:
 - ✓ UOQ operative bed scarring with related focal area of parenchymal distortion.
 - ✓ diffuse skin thickening reaching (7 mm).
 - ✓ No gross suspicious operative bed masses
- No left breast suspicious mass lesions, micro calcifications or architectural distortion detected.
- Normal skin thickness and nipple areola complex, with average caliber of the retro areolar ducts of the left breast.
- No pathological axillary lms
- Free right infra and supra clavicular regions.

Opinion:

- Post right CBS showing operative bed changes with no evidence of recurrent mass lesions (BIRADS 2)
- Normal study of the left breast (BIRADS 1)

Yours truly

Dr. Peter Fakhry